



# VENERE

## Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Costruiamo il primo operatore nazionale convertendo centri estetici in cliniche: aggiungiamo la medicina estetica su footfall e clientela già esistenti, industrializzata da un playbook di autorizzazioni e da medici condivisi. Sopra, un dataset clinico proprietario che nel tempo industrializza la qualità e riduce la dipendenza dal medico.

# Un mercato grande, senza un proprietario, con la finestra aperta

**800k+**

procedure l'anno in Italia  
(500k non chirurgiche,  
300k interventi)

**90%+**

studi indipendenti e mono-  
medico: nessuna catena  
domina

**<5**

consolidatori, tutti early-  
stage (Klinicy, Faceland): il  
capitale è appena entrato,  
finestra ancora aperta

**36k**

centri estetici: l'universo  
che medicalizziamo, ben  
oltre le poche cliniche  
mediche in vendita

## L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il  
capitale istituzionale arriverà anche in  
Italia: chi costruisce prima detta i prezzi.

## Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano  
domanda ricorrente: rimodellamento e  
skin quality post-dimagrimento.

## Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza  
successori: venditori motivati, aperti a  
earn-out e permanenza clinica.

*È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Il nostro ingresso è la coda lunga dei centri estetici (a sconto) da medicalizzare: ogni trimestre di attesa alza i multipli.*

PERCHÉ ORA, E PERCHÉ IN ITALIA

# Cinque forze convergono su questa finestra. Non dureranno.

## Consolidamento appena iniziato

Solo 1-2 player early-stage (Klinicy, Faceland): multipli ancora a 3-4x. Il PE è entrato ora, la finestra si sta chiudendo.

## Ondata di venditori adesso

Ricambio generazionale: titolari verso la pensione senza successori, aperti a earn-out e rollover. Vendono ora.

## Domanda in accelerazione

L'onda GLP-1 crea domanda ricorrente (skin quality e rimodellamento post-dimagrimento) proprio in questi anni.

## L'Europa ha dato il segnale

UK e Spagna già consolidate: il capitale arriverà anche qui. Chi costruisce prima diventa la piattaforma da comprare.

## L'AI è matura adesso

Per la prima volta agenti e modelli reggono operations multi-sede e decision-support. Chi parte oggi AI-native accumula il dataset.

**Il punto sul timing:** queste forze non aspettano. Ogni trimestre di attesa **alza i multipli d'acquisto**, riduce i venditori disponibili e, poiché **i dati compongono**, regala a un altro il vantaggio informativo che non si recupera. Il primo che parte non compra solo cliniche: compra il tempo.

# Il modello ha già vinto: USA medspa, dentale e farmacie italiane

## USA · Medspa: la scala paga

- ◆ Studio mono-medico 3-6x EBITDA; piattaforma recurring 30%+ a 7-12x
- ◆ I membri valgono 4,8x il lifetime value e spendono +35% a visita
- ◆ 2026 anno record M&A: LaserAway in vendita >2 mld \$

## Italia · Sanità-retail: già eseguito qui

- ◆ Stessa struttura: mono-professionista, contabilità artigianali, zero brand
- ◆ Dentale (DentalPro) e farmacie (Hippocrates): da studi grigi a catene nazionali via PE
- ◆ Vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

**La medicina estetica ha 3 vantaggi strutturali:** 100% pay-per-service senza convenzioni, ricorrenza naturale 3-4 visite/anno, margini lordi superiori sugli iniettabili.

# Due motori: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato



Compriamo **asset che generano già cassa** (centri estetici a sconto, cliniche in successione) e li **medicalizziamo** con un format replicabile e due macchine: **playbook autorizzazioni** e **medici condivisi**. Anche senza espansione dei multipli, la crescita dell'EBITDA e la scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

# Perché è fattibile e veloce: convertiamo centri estetici in cliniche

Non partiamo dalle poche cliniche mediche in vendita (scarse, care, contese). Partiamo dai **centri estetici**: universo enorme, economico, con clientela e footfall già attivi, e ci **aggiungiamo la medicina estetica**. Due playbook industrializzati tolgono i colli di bottiglia che fermano tutti gli altri.

## 1 • Playbook autorizzazioni

L'autorizzazione sanitaria è lo step lento: lo industrializziamo. Filtro di convertibilità pre-deal, template di sede medica, partner regolatorio, relazioni con ATS/Comune. **Da mesi bespoke a settimane ripetibili.**

## 2 • Medici condivisi

Un **pool di medici che ruota part-time** su più sedi (come già fa il nostro CMO): medicalizzi molte sedi con pochi medici, ogni sede subito profittevole (niente medico full-time).

## 3 • La fiducia è già del centro

Il cliente è fedele **all'insegna, non a un medico**. Medicalizzando ereditiamo quella fiducia e una base clienti già calda: il paziente resta legato **a noi, non al singolo medico**. La dipendenza dal medico (rischio n°1) è disinnescata all'origine.

**Il roll-up rotola davvero.** Il centro estetico paga l'affitto col non-medico mentre medicalizzi; il medico condiviso aggiunge margine alto a costo fisso basso; il playbook autorizzazioni replica sede dopo sede. Ogni conversione è un'unità piccola, economica, veloce e ripetibile: dove Kliniky e Faceland comprano cliniche mediche care e un medico per sede, noi convertiamo sedi economiche con medici condivisi.

# Sei caratteristiche: cosa applichiamo a ogni sede (clinica o centro medicalizzato)

## **Recurring su prescrizione**

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

## **Multi-provider by design**

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

## **Mix clinico completo**

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

## **Patient journey da retail**

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

## **Pagamenti rateali**

Rateizzazione a tasso zero: alza il ticket e apre la fascia 25-40, già abituata al buy-now-pay-later.

## **Gestione manageriale**

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

*Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.*

# La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: **è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso**. Chi porta trasparenza cattura il re-rating, come nel dentale/diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme premium).

## **Rate = tracciabilità**

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato. Formalizzi crescendo.

## **Rollover in equity**

Il titolare (del centro estetico o della clinica) reinveste parte del prezzo in una quota della piattaforma: trasforma reddito personale in capitale tassato e si allinea all'exit di gruppo.

## **Compliance = multiplo**

Un asset pulito e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo, ed è il moat.



# L'AI non è una promessa a 10 anni: crea valore su tre orizzonti

## OGGI · MARGINE

### Operations AI-native

Agenti gestiscono agende, recall, pricing, procurement e KPI. **HQ snello, integrazione più rapida, margini migliori da subito**: il vantaggio operativo che uno studio da solo non ha.

## MEDIO · QUALITÀ

### AI decision-support

Sul dataset reale del gruppo l'AI suggerisce piano e dosaggio, standardizza la qualità e **riduce la dipendenza dal singolo medico** (il rischio n°1). Il medico decide.

## LUNGO · COSTO

### Automazione

Il dataset di outcome è il substrato per **l'automazione delle procedure standardizzate**: attacca il costo e il collo di bottiglia dell'ora-medico.

**Azienda AI-driven end-to-end (modello Bending Spoons).** Lo stesso layer AI che fa girare le sedi guida la **macchina di M&A**: origination e scoring dei target, filtro di convertibilità autorizzativa, due diligence e integrazione a 100 giorni. Il dataset proprietario di outcome è ciò che la finanza da sola non compra: sposta la valutazione verso un multiplo AI-platform ed è il moat che rende il roll-up di questo team difendibile.

# La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto

## Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazione per struttura; medici condivisi tra sedi; area estetica non-medica separata dall'atto medico; piena autonomia clinica.

## Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

## Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit.

## Incentivi $\neq$ volumi

Mai bonus sul venduto: sicurezza e retention.

## Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e consulenza.

## Soglie reputazionali

KPI con blocco espansione al bisogno.

# Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

## Due tipi di target

- ◆ **Centri estetici** da medicalizzare: footfall, clientela fedele, sede convertibile
- ◆ **Cliniche** avviate: ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+, iniettabili prevalenti
- ◆ Sede **convertibile ad ambulatorio** (destinazione d'uso, requisiti): filtro pre-deal
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster (Milano first, poi NO/NE)
- ◆ Titolare disponibile a permanenza + rollover

## Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

## Pipeline proprietaria

Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili/dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor di consolidamenti sanitari italiani. Il deal flow migliore non passa dai broker.

## ROADMAP

# Dal format lab al primo operatore nazionale

### FASE 1 · MESI 0-18

#### Provare la conversione

Format lab + prime conversioni (centri estetici medicalizzati) a Milano. Prova playbook autorizzazioni e tasso di conversione. Avvio raccolta dati.

**conversione provata, EBITDA/sede +30%**

### FASE 2 · MESI 18-36

#### Densità regionale

8-12 cliniche in 2-3 cluster. Playbook 100 giorni, procurement pieno, brand, leva bancaria.

**10+ sedi, recurring 20%+, EBITDA 4-6M**

### FASE 3 · MESI 36-60+

#### Scala nazionale ed exit

20-30 cliniche + dataset maturo. Target dei consolidatori PE / device-maker.

**exit 7-10x, upside med-tech**

*Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).*

# L'economia di una conversione: centro estetico medicalizzato

| Centro estetico | All'acquisto | Medicalizzato (24 mesi) |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| Ricavi          | 0,60M        | <b>1,00M</b>            |
| Margine EBITDA  | 15%          | <b>28%</b>              |
| EBITDA          | 90k          | <b>280k</b>             |

*Numeri illustrativi da benchmark, da validare in DD.*

## + Medicina estetica

Medico condiviso part-time sulla base clienti esistente: injectables ed energy-based ad alto margine.

## Comprato ~3x (270k)

+ capex conversione ~150-300k (autorizzazione, sale, device). Il non-medico paga l'affitto durante la conversione.

## Ritorno

280k EBITDA a regime; a multiplo medico 8x vale ~2,2M: doppio arbitraggio (sconto + re-rating).

# Il consolidamento è appena iniziato, e nessuno ha il nostro angolo

|                    | Modello                                           | Backer                 | Recurring      | Dato + AI |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| Klinicy            | Buy-and-build cliniche estetiche (5 acquisizioni) | Investitori privati    | Limitato       | No        |
| Faceland · Juneco  | Catena medico-estetica low-cost, greenfield + M&A | Verlinvest (BE)        | Limitato       | No        |
| epiLate            | Rete centri estetici (epilazione), mono-servizio  | VERTEQ + SICI          | Sì (pacchetti) | No        |
| Studi indipendenti | Mono-medico, artigianale                          | No                     | Sì (titolare)  | No        |
| VENERE             | Buy-and-build + format + formalizzazione          | Family office + debito | Cuore (30%)    | Sì · moat |

**Il consolidamento è partito (Klinicy, Faceland): la finestra è aperta ma si chiude.** Loro consolidano; nessuno però unisce **dati + AI proprietari, formalizzazione del nero** come motore di valore e **credibilità clinica** di partner medici. La velocità è la difesa: chi arriva primo con format e dataset diventa la piattaforma che gli altri compiranno.

## IL TEAM

# Visione, AI, clinica, operations: competenze complementari



**Luca Martino**

**FOUNDER & CEO**

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Visione, capitale, M&A, investitori.



**Salvatore Diana**

**CHIEF AI OFFICER**

Architetto della piattaforma agentica e del dataset proprietario: outcome tracking, AI decision-support e la roadmap verso l'automazione. Il moat che la finanza non compra.



**Marcello Cammalleri**

**CHIEF MEDICAL OFFICER**

Medico chirurgo estetico: protocolli, format clinico, reclutamento medici e deal flow. Sotto il comitato scientifico indipendente.



**COO**

**OPERATIONS · TBH (TO BE HIRED)**

Reti multi-sede in sanità e consumer premium. Format e P&L per sede, patient journey, integrazione a 100 giorni.

Contrappesi per costruzione: CFO espresso dagli anchor investor; deal team M&A; comitato scientifico indipendente sopra il CMO; consigliere indipendente in board; advisor regolatorio-sanitario, fiscale-M&A e da consolidamenti sanitari italiani già eseguiti.

L'ORIZZONTE

# Un asset che l'AI non erode ma potenzia, con un secondo atto oltre i 10 anni

## Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

## Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il #1 nazionale: la scala lavora a favore.

## Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

VENERE · Riservato e confidenziale



# Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

## Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

## Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

## Autorizzazioni sanitarie

Filtro di convertibilità pre-deal (destinazione d'uso, requisiti) + playbook autorizzazioni + advisor regolatorio: compriamo solo sedi convertibili.

## Conversione beauty → medico

Tasso di conversione provato su 1-2 sedi prima di scalare; il ricavo non-medico copre i costi durante la medicalizzazione.

## Esecuzione M&A

Playbook 100 giorni nel software, Fase 1 piccola per raffinare il metodo prima di scalare.

## Consolidatori esteri

La velocità è la difesa: chi ha già cluster e format diventa la piattaforma da comprare.

*Il rischio n°1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.*

# Raccolta iniziale: 4 milioni per avviare la piattaforma

**70%**

Prime conversioni e cliniche (equity + leva in Fase 2)

**15%**

Capex del format: offerta, dispositivi, restyling

**10%**

Piattaforma centrale: management, M&A, brand, software

**5%**

Riserva operativa e costi di transazione

**Struttura:** club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO dagli anchor), tranche legate a milestone. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x, con upside dal dataset.

**Primo passo:** commitment sulla **Fase 1 (4M)** per le prime cliniche e la prova del format, con prelazione sulle tranche successive.



# VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica, e la piattaforma di dati che lo rende difendibile nel tempo.

Convertiamo centri estetici in cliniche aggiungendo la medicina estetica, con un playbook di autorizzazioni e medici condivisi; formalizziamo un settore grigio e costruiamo il dataset che industrializza la qualità. Un mercato grande e frammentato, con la finestra ancora aperta.